

Yth.

1.

PLT Direktur RS. Prima Husada Malang
2.

Direktur RS. Prima Husada Sukorejo

SURAT EDARAN

NOMOR: 088/DPM/I-SE/DIR/II/2026

TENTANG

INDIKATOR MUTU PENGELOLAAN KLAIM BPJS KESEHATAN DAN
MUTU LAYANAN PASIEN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Berdasarkan hasil evaluasi berkala terhadap pelayanan dan proses klaim BPJS Kesehatan selama periode Tahun 2025, diperlukan perbaikan dari seluruh aspek utama, yaitu sistem, administrasi, klinis, dan *coding* melalui penetapan indikator mutu yang berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk mengevaluasi, memonitor, serta meningkatkan standar kualitas klaim dan pelayanan.

Berikut adalah **indikator mutu** yang wajib digunakan tiap unit di lingkup RS Prima Husada Group untuk **pengelolaan klaim asuransi kesehatan berkualitas**:

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	UNIT
1	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5 Awal Bulan	Asuransi Center
2	% Klaim Pending RJTL	<0,1% dari total klaim	
3	% Klaim Pending RITL	<1% dari total klaim	
4	% Klaim Tidak Layak	0% dari total klaim	
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	< Rp 1.000.000	
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	< Rp 5.000.000	
7	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL	< Rp 50.000.000	
8	Nilai Selisih Negatif Klaim RITL	< Rp 100.000.000	

Berikut adalah indikator mutu yang wajib digunakan tiap unit di lingkup RS Prima Husada Group untuk memastikan **pelayanan pasien BPJS Kesehatan berjalan sesuai dengan standar** yang ditetapkan:

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	UNIT
1	Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan	Jadwal praktik 100% sesuai = 100	• IRJA • SDM
		Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75	
		Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50	
		Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25	
		Jadwal praktik <20% sesuai = 0	
		Tidak ada kunjungan = 100	

2	Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100	MOD
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75	
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50	
		Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0	
3	Umpan Balik Peserta (<i>Customer Feedback</i>)	Σ responden 100% target = 100	MOD
		Σ responden 75 - 99% target = 75	
		Σ responden 50 - 74% target = 50	
		Σ responden 25 - 49% target = 25	
		Σ responden <25% target = 0	
4	Update Data Ketersediaan Tempat Tidur	Σ update $\geq$ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100	• IRNA • MOD
		Σ update $\geq$ 25 hari = 75	
		Σ update 15 - 24 hari = 50	
		Σ update 10 - 14 hari = 25	
		Σ update < 10 hari = 0	
5	Update Jadwal Tindakan Medis Operatif	Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100	• MOD • IKO
		Tidak menginput jadwal TMO = 0	
6	Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN dan Waktu Tunggu Rawat Jalan	Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100	• IRNA • PDF
		Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75	
		Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50	
		Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25	
		Pemanfaatan MJKN $\leq$ 70% target = 0	
7	Penerbitan Surat Kontrol	Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100	• IRJA • PDF
		Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75	
		Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50	
		Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25	

		Surat Kontrol terbit $\leq 50\%$ sesuai = 0	
8	Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik	RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100	• Kabid Yanmed • IT Programmer
		RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75	
		RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50	
9	% Approval SEP	0%	TPP
10	Angka Capaian Iterasi	Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di wilayah masing-masing, lalu di buat standar bulanan	• IRJA • Farmasi
11	Angka Capaian PRB	Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di wilayah masing-masing, lalu di buat standar bulanan	• IRJA • Farmasi
12	Kepatuhan CP sesuai PPK yang berdampak pada mutu dan biaya	100%	• Kabid Yanmed • Komite Medik

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 20 Januari 2026
Direktur PT Disa Prima Medika,



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE

Lampiran : I (Satu)
Nomor : 088/DPM/I-SE/DIR/I/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

Indikator mutu **pengelolaan klaim asuransi kesehatan berkualitas** poin 2- 8 wajib dilakukan analisis dengan 4 aspek yaitu

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis			
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan			
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku			
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostic sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku			

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 20 Januari 2026
Direktur PT Disa Prima Medika,



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE

Lampiran : 2 (Dua)
Nomor : 088/DPM/I-SE/DIR/I/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

Daftar Panduan Praktik Klinis (PPK) yang wajib disusun oleh masing-masing Rumah Sakit untuk pemenuhan indikator mutu **pelayanan pasien BPJS Kesehatan poin 12** :

1. Typhoid Fever (Dewasa dan Anak)
2. Dengue Fever (Dewasa dan Anak)
3. Pneumonia Dewasa
4. Pneumonia Bayi dan anak
5. DM gangren/ulcus dengan Tindakan Debridement
6. Soft Tissue Tumor dengan tindakan eksisi

Keterangan :

Pemilihan PPK berdasarkan diagnosis terbanyak di tahun 2025

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 20 Januari 2026
Direktur PT Disa Prima Medika,



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE